

요로감염(UTI) (UTIs)

WARWIKI

환자 안내문 · 요로감염이란 무엇인지, 치료 방법 및 예방법

요로감염(UTI)은 세균이 요로에서 증식할 때 발생합니다. 대부분은 방광 감염(방광염)으로, 배뇨 시 작열감·절박뇨·빈뇨를 일으킵니다. 감염이 신장까지 올라가는 경우는 더 심각합니다. 대부분의 요로감염은 적절한 항생제로 빠르게 호전되며, 재발을 예방하는 좋은 방법도 있습니다.

이 질환에 대하여

방광염(cystitis)의 주요 증상:

- 소변을 볼 때 **작열감**이나 **따가운 느낌**
- **절박뇨와 빈뇨** — 소량씩 자주 소변을 보게 됨
- 탁하거나 진하거나 냄새가 강한 소변; 하복부 불편감

신우신염(pyelonephritis)은 더 심각하며, **발열·오한·요통** 또는 **옆구리 통증·오심**이 동반됩니다 — 신속한 치료가 필요합니다.

원인

장에서 유래한 세균이 요도를 통해 방광으로 들어와 증식합니다. 위험 인자로는 **성관계**, **폐경**(에스트로겐 감소), 방광을 완전히 비우지 못하는 경우, 도뇨관, 결석, 당뇨 등이 있습니다.

용어 설명

요로감염(UTI)

요로 어디서든 발생하는 감염.

방광염(Cystitis)

방광 감염 — 가장 흔한 요로감염.

신우신염(Pyelonephritis)

신장 감염 — 더 심각하며 발열을 동반하는 경우가 많음.

소변 배양 검사

세균을 배양하여 적합한 항생제를 선택하는 검사.

재발성 요로감염

반복적인 감염(보통 연간 2-3회 이상).

질 에스트로겐

폐경 후 요로감염 위험을 낮추는 저용량 크림/정제.

무증상 세균뇨

증상 없이 소변에 세균이 있는 상태 — 보통 치료하지 않음.

항생제가 항상 필요한가요? 증상이 있으면 항생제로 치료합니다. 그러나 소변 검사에서 세균이 검출되어도 **증상이 없으면** 일반적으로 치료하지 않습니다 — 이 경우 항생제는 득보다 해가 많습니다. 임신 중이거나 특정 요로 시술 전에는 예외가 적용됩니다.

진단 방법 및 치료 방법

- 의료진은 **증상**과 **소변 검사/배양**으로 요로감염을 확인합니다.
- 방광염은 **단기간 항생제 치료**로 관리합니다.
- **신우신염**은 더 강하거나 긴 항생제 치료가 필요하며, 입원이 필요할 수도 있습니다.
- 호전된 후에도 처방된 항생제를 끝까지 복용하세요.

재발 예방

- 물을 **충분히 마시고** 소변을 오래 참지 마세요.
- 성관계 후 소변을 보고, 앞에서 뒤로 닦으세요.
- 폐경 후에는 **질 에스트로겐**이 위험을 낮출 수 있습니다.
- 비항생제 요법에 대해 문의하고, 감염이 잦을 때만 예방적 항생제를 고려하세요.

알아두세요

- 크랜베리 제품과 D-만노스는 도움이 되는 경우도 있으나 근거가 엇갈립니다 — 시도해 볼 수는 있습니다.
- 반복되는 요로감염은 원인 확인(방광 미완전 배뇨, 결석)이 필요할 수 있습니다.
- 도뇨관이 있으면 세균이 검출될 수 있습니다 — 치료는 검사 결과가 아니라 증상을 기준으로 합니다.

다음 증상이 있으면 즉시 의료진에게 연락하세요:

- **발열, 오한, 또는 허리/옆구리 통증** (신우신염 가능성)
- 오심·구토 또는 심한 전신 불편감
- 육안적 **혈뇨**, 또는 항생제 복용 후에도 증상이 호전되지 않는 경우
- 임신 중 요로감염 증상이 있는 경우

기억할 세 가지

1. 대부분의 요로감염은 방광염(작열감·절박뇨)이며 단기 항생제로 호전됩니다. 신우신염(발열·옆구리 통증)은 더 심각합니다.
2. **증상 없이** 세균만 있는 경우는 임신 중이거나 특정 시술 전이 아니면 치료하지 않습니다.
3. 수분 섭취, 성관계 후 배뇨, 폐경 후 질 에스트로겐으로 예방하세요. 발열·옆구리 통증·구토 시 즉시 진료받으세요.